

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE 3 DE CONSTANTINE

DEPARTEMENT DE MEDECINE

FACULTE DE MEDECINE

ENSEIGNEMENT DU MODULE D' HEPATOASTROENTEROLOGIE (4^{ème} Année de Médecine)

L'AMPULLOME VATERIEN

Enseignant : Pr R.KHENNAOUI

Service des Urgences Chirurgicales – CHU Constantine

I - DEFINITION

Un ampullome Vatérien désigne l'ensemble des tumeurs bénignes et malignes issues de la zone du confluent bilio- pancréaticoduodénal délimitées par l'appareil sphinctérien : le Sphincter d'ODDI.

L'ampullome Vatérien peut être dénommé une tumeur vatérienne, une tumeur oddienne, ou tumeur de la région oddienne.

II - RAPPEL ANATOMOPHYSIOLOGIQUE

L'ampoule de Vater (ou ampoule hépato pancréatique): structure anatomique où le canal biliaire (cholédoque) et le canal pancréatique (de Wirsung) se rejoignent pour se jeter dans le duodénum.

L'ampoule de Vater(ampoule hépato pancréatique) : enveloppée par le [sphincter d'Oddi](#), un muscle qui contrôle le flux de la bile et du suc pancréatiques dans le duodénum, et se termine par une petite saillie appelée [papille duodénale](#) .

De par sa localisation anatomique dans le duodénum, l'ampoule de Vater est un site anatomique complexe, avec une intrication de 3 épithelia :

- Celui de la muqueuse duodénale

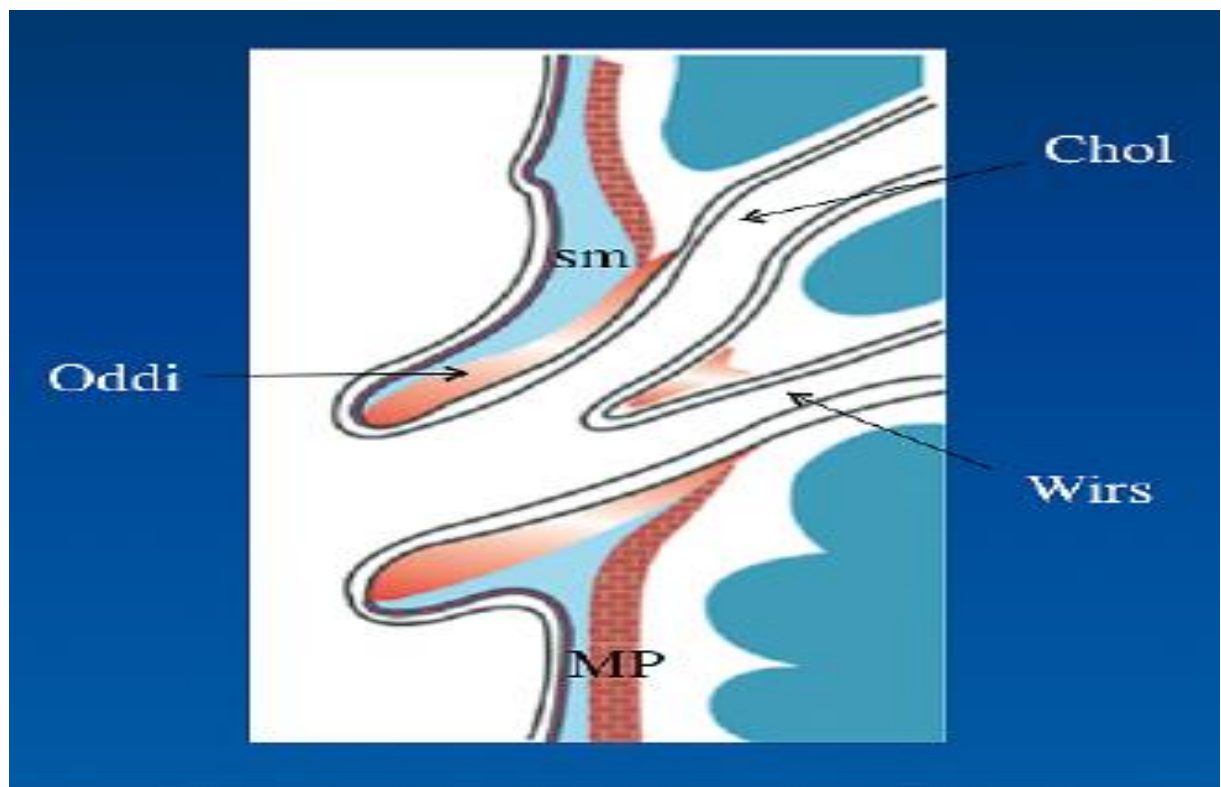
- de l'épithélium ductal bordant les canaux pancréatiques
- et le canal biliaire principal.

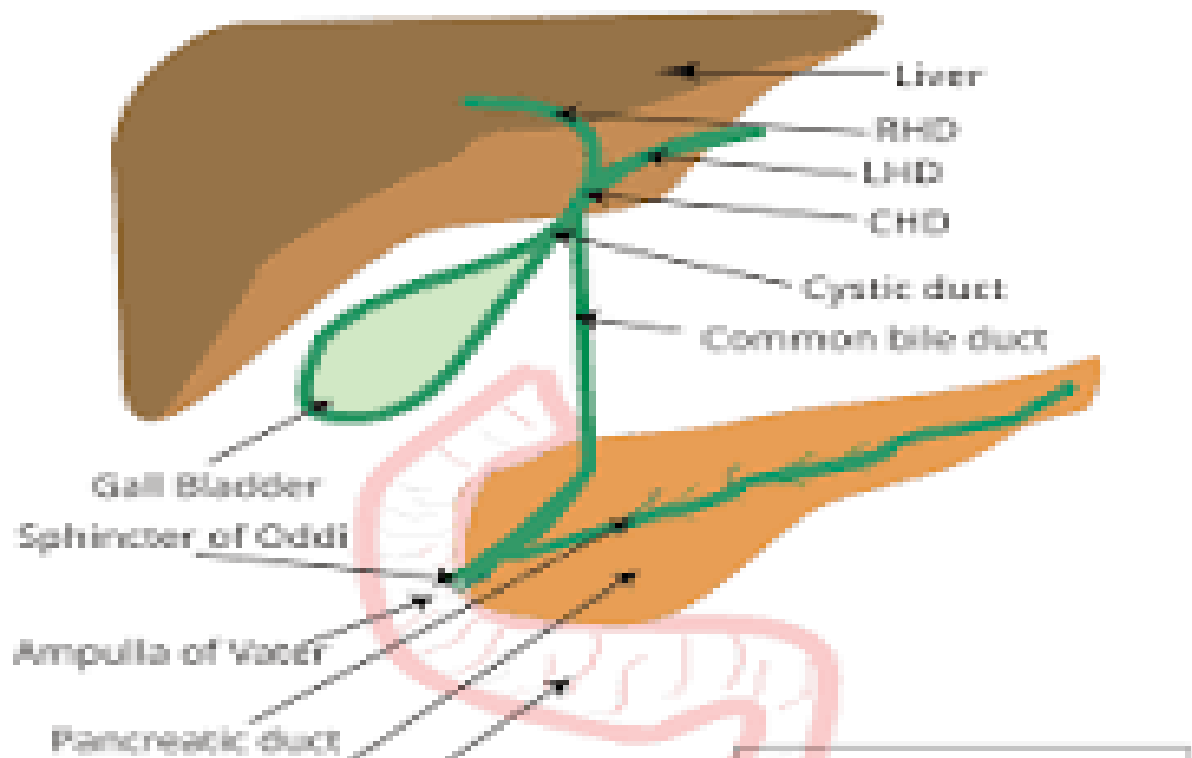
L'ampoule de Vater est le plus souvent située à la face interne du 2^{ème} duodénum, mais parfois dans le genu inferius ou le début du 3^{ème} duodénum, au niveau d'une zone de

faiblesse de la paroi, sans musculature (musculaire propre du duodénum) , l'ampoule de Vater est entourée par le sphincter d'Oddi.

Vascularisation

- Les branches artérielles destinées à la papille sont les artères pancréatico-duodénales supérieures et inférieures et les artères communicantes.
- Le drainage veineux de l'ampoule se fait principalement vers les veines pancréatico-duodénales, qui se jettent ensuite dans le système porte hépatique, qui est un réseau complexe de veines transportant le sang vers le foie.
- Les relais ganglionnaires locorégionaux sont les mêmes que pour la tête du pancréas (face antérieure et face postérieure).





III- EPIDEMIOLOGIE

L'ampullome Vatérien est une tumeur rare : 0,6 à 0,8 % de l'ensemble des cancers digestifs

Elles sont généralement diagnostiquées entre 50 - 70 ans. La prédominance masculine est très marquée.

- Facteurs de risque :

Polypose recto colique, syndrome de GARDNER, lithiase biliaire, adénome sous jacent.

IV- ANATOMIE PATHOLOGIQUE

La prédominance des tumeurs malignes est très nette.

1- Les tumeurs bénignes : $\leq 5\%$

2- Les tumeurs malignes : épithéliales 95 %

- Exo ampullaires peuvent être ulcéro- végétantes ou végété infiltrantes (+)
- Intra ampullaires (endobiliaire ou endo canalaire) ou endoampullaires (+)

Formes mixtes (+++) : sont les plus fréquentes.

Classification TNM

T

- Tx : Non évaluable
- T0 : Pas de tumeur primitive
- Tis : Carcinome in situ / dysplasie de haut grade
- T1a : Tumeur limitée à l'ampoule de Vater ou au sphincter d'Oddi
- T1b : Tumeur dépassant le sphincter d'Oddi (invasion péri-sphinctérienne) et/ou envahissant la sous-muqueuse du duodénum
- T2 : Tumeur envahissant la musculature (muscularis propria) du duodénum
- T3

T3a : Tumeur envahissant le pancréas

T3b : Envahissement ≤ 5 mm dans le pancréas Envahissement > 5 mm dans le pancréas, ou envahissant le tissu péri pancréatique ou la séreuse duodénale mais sans extension à l'axe cœliaque ou à l'artère mésentérique supérieure

- T4 : Atteinte du tronc cœliaque, de l'artère mésentérique supérieure et/ou de l'artère hépatique commune

N

- Nx : Non évaluable
- N0 : Pas de métastase ganglionnaire régionale
- N1 : 1 à 3 métastases ganglionnaires régionales
- N2 : ≥ 4 métastases ganglionnaires régionales**

M

- M0 : Pas de métastase à distance
- M1 : Métastase(s) à distance

La classification japonaise des ampullomes vatriens distingue les lésions en fonction de leur profondeur d'invasion et de leur risque ganglionnaire.

- La classification d0 : concerne les tumeurs limitées à l'ampoule sans invasion de la sous-muqueuse duodénale et sans emboles vasculaires, avec un pronostic favorable (survie à 5 ans de 100 %) et un risque ganglionnaire nul.

- La classification d1 : inclut les tumeurs qui envahissent la sous-muqueuse duodénale ou qui présentent des emboles vasculaires, associées à un risque plus élevé d'atteinte ganglionnaire (30 %) et une survie à 5 ans réduite à 65 %.

V- ETUDE CLINIQUE

Dans environ 40 % l'ampullome est découvert du fait de manifestations cliniques ou biologiques.

Dans environ 60 % les signes cliniques sont absents, l'ampullome Vaterien est découvert suite à la réalisation d'une endoscopie digestive haute (EDH) pour motif variable hémorragie, douleurLa pratique d'une Tomodensitométrie pour une pancréatite aigue.

La découverte d'une tumeur de l'ampoule de Vater peut être annoncée par des signes obstructifs :

- Douleur biliaire
- Douleur épigastrique (+++)
- Ictère / phase anictérique →+++++++
- Prurit
- Hémorragie digestive
- Pancréatite
- Angiocholite
- Une anémie

L'anamnèse recherche des antécédents de Polyadénomatose.

VI- EXAMENS PARACLINIQUES

1- Biologie

- Ictère rétionnel : BRBT, BRBd, Phosphatases alcalines , GGT, TP bas , TGO,TGP.....
- NFS : anémie (+++)

2- Radiologie

- Echographie abdominopelvienne: dilatation de la voie biliaire principale, métastases
- Duodéroscope (latéroscope haute définition): permet surtout la réalisation des biopsies.

Autres explorations :

- L'Echo endoscopie et exploration intra canalaire par mini sonde d'endoscopie avec biopsies à la pince
- Tomodensitométrie thoracoabdominopelvienne (bilan d'extension)

Bilan pour indications thérapeutiques (+++)

- Cholangio –pancréato - IRM : extension tumorale intra canalaire
- Gastroskopie : recherche de lésions associées
- Coloscopie : recherche de lésions associées
- [Choangiopancréatographie rétrograde endoscopique](#)

Il s'agit d'un examen qui permet de visualiser le canal biliaire principal, le cholédoque (qui draine les canaux biliaires hépatiques) et le canal de Wirsung.

VII- DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- Cholangiocarcinome du tiers inférieur du cholédoque
- Cancer de la tête du pancréas
- Oddite scléreuse
- Calcul enclavé dans le bas cholédoque

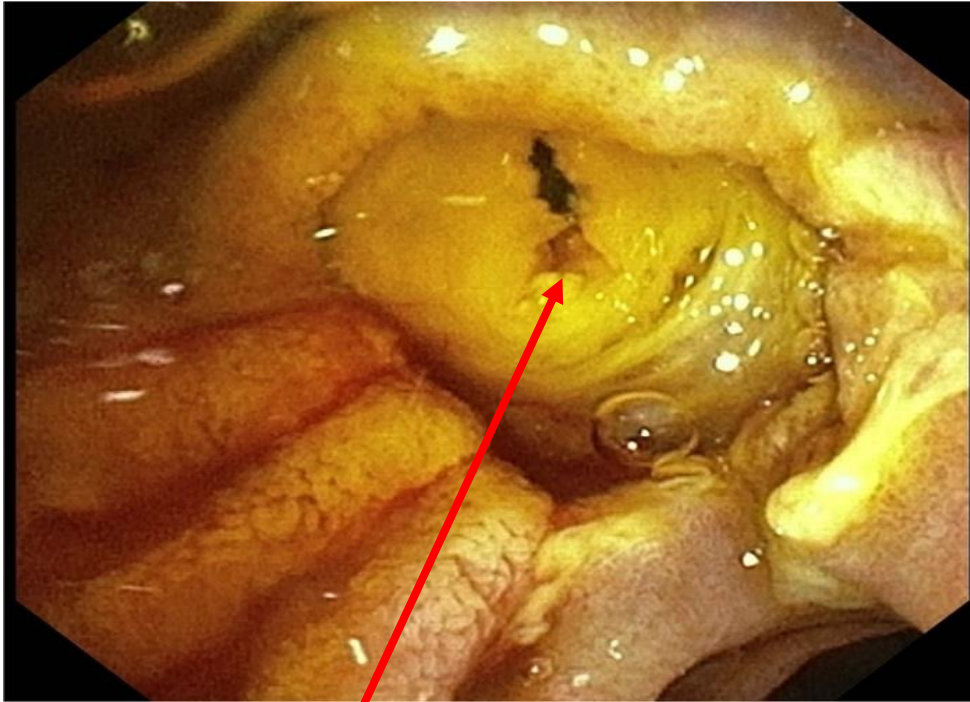
VIII- TRAITEMENT

1- A visée curative :

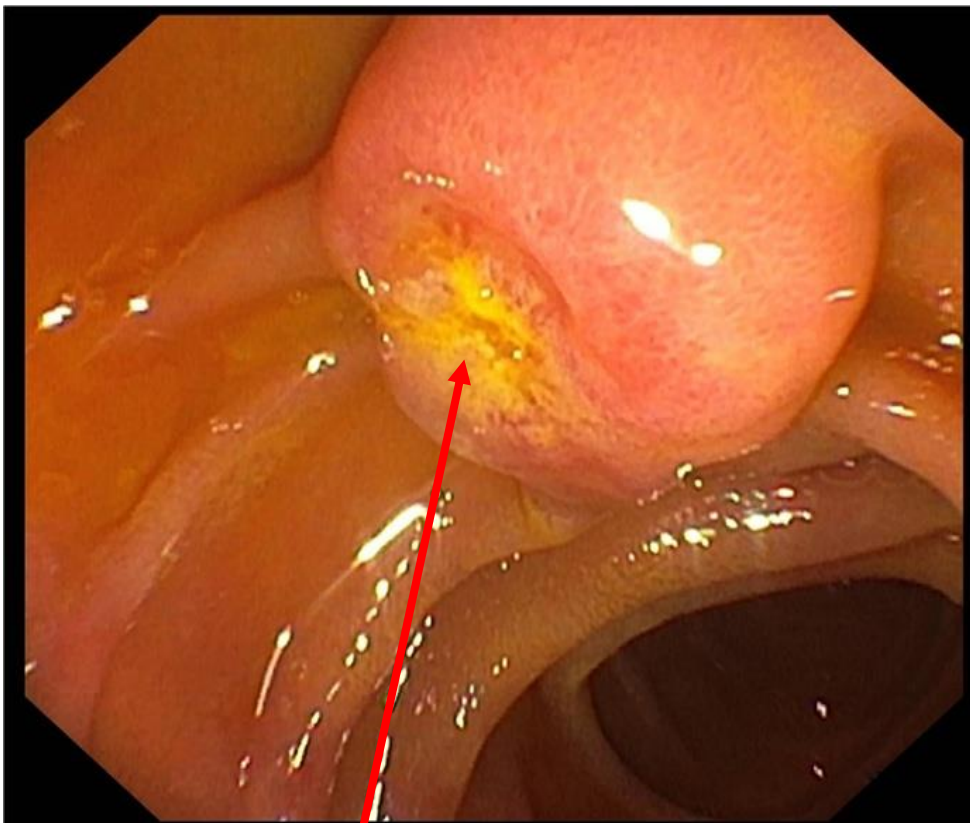
- Résection endoscopique :

L'ampullectomie endoscopique est devenue le traitement de première intention des adénomes et adénocarcinomes superficiels, sans envahissement : AMPULLOMES BENINS de moins de 03 cm

- Ampullectomie chirurgicale : papillectomie trans duodénale
- Duodénopancréatectomie céphalique (DPC)



Ampullome Vatérien(EDH)



Un géant ampullome Vatérien (EDH)

2- A visée palliative :

- Endoscopique : Laser Yag, photothérapie, SE, double prothèse: si obstruction biliaire et / ou digestive

- Dérivation biliaire : dérivations biliodigestives
- Gastroentérostomie (anastomose gastro jéjunale)

CONCLUSION

L'adénome ampullaire est découvert fréquemment de façon fortuite et pour la plupart des cas accessible au traitement endoscopique (résection endoscopique) .La confirmation diagnostique se fait sur des prélèvements histologiques .Le suivi des patients doit être

IX- Références bibliographiques

1. Kim MH, Lee SK, Seo DW, Won SY, Lee SS, Min Tumors of the major duodenal papilla. *Gastrointest Endosc.* nov 2001;54(5):609-20.
2. Matsumoto T, Iida M, Nakamura S, Hizawa K, Yao T, Tsuneyoshi M, *et al.* Natural history of ampullary adenoma in familial adenomatous polyposis: reconfirmation of benign nature during extended Am J Gastroenterol. juin 2000;95(6):1557-62.
3. Burke CA, Beck GJ, Church JM, van Stolk The natural history of untreated duodenal and ampullary adenomas in patients with familial adenomatous polyposis followed in an endoscopic surveillance program. *Gastrointest Endosc.* mars 1999;49(3 Pt 1):358-64.
4. Roh YH, Kim YH, Lee HW, Kim SJ, Roh MS, Jeong JS, *et al.* The clinicopathologic and immunohistochemical characteristics of ampulla of Vater carcinoma: the intestinal type is associated with a better Hepatogastroenterology. sept 2007;54(78):1641-4.
5. Kimchi NA, Mindrul V, Broide E, Scapa The contribution of endoscopy and biopsy to the diagnosis of periampullary tumors. *Endoscopy.* août 1998;30(6):538-43.
6. Bellizzi AM, Kahaleh M, Stelow EB. The assessment of specimens procured by endoscopic ampullectomy. *Am J Clin Pathol.* oct 2009;132(4):506-13.
7. Miyazaki M, Ohtsuka M, Miyakawa S, Nagino M, Yamamoto M, Kokudo N, *et al.* Classification of biliary tract cancers established by the Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery: 3(rd) English J Hepatobiliary Pancreat Sci. mars 2015;22(3):181-96.
8. Riditid W, Schmidt SE, Al-Haddad MA, Le Blanc J, De Witt JM, McHenry L, *et al.* Performance characteristics of EUS for locoregional evaluation of ampullary lesions. *Gastrointest févr* 2015;81(2):380-8.

